



Nomor : 2381/VII-05/0724

Malang, 16 Juli 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Kegiatan Audit Medis TKMKB Rehab Medik

Yth.

1. Direktur RS Hermina Tangkubanprahu

2. Direktur RS Prima Husada

di

Malang

Pertama-tama kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Malang menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Bersama ini disampaikan Laporan Kegiatan Audit Medis TKMKB Rehab Medik (terlampir). Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang



Roni Kurnia Hadi Permana

Tembusan: Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang

AN/de/pk00

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. Raden Tumenggung Suryo 44 Malang

Telp. +62 341 493026

Fax. +62 341 493802

www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT CABANG MALANG

LAPORAN KEGIATAN AUDIT MEDIS TKMKB CABANG MALANG TAHUN 2024

I. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Jenis Kegiatan : Audit Medis
- b. Pelaksana Kegiatan : Anggota TKMKB Cabang
 - 1. dr. Sasmojo Widito, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FSCAI
 - 2. dr. Rahmad, Sp.KFR.K.R. (K)
- c. Tanggal Kegiatan : 06 Mei 2024
- d. Tema Kegiatan : Evaluasi Layanan Rehabilitasi Medik bagi peserta JKN
- e. Lokus Audit : RS Prima Husada

II. Hasil Kegiatan

1. Temuan Hasil Audit Medis:

Setelah dilakukan audit terhadap 11 pasien pelayanan tahun 2018-2024

No	Audit	Jenis	Sesuai/ Tidak	Uraian Masalah	Keterangan
1	Kesesuaian PPK (PPK yang sesuai PNPK terbaru)	Diagnosa	Sesuai		
		Tata laksana	Tidak Sesuai	Belum ada pencatatan terapi rehab selesai dan jawaban ke DPJP pengkonsul dan/atau FKTP	
2	Kesesuaian klaim dengan standar pelayanan medis	Diagnosa	Sesuai		
		Tata laksana	Tidak sesuai	Ketidakpatuhan frekuensi pelayanan sesuai protokol karena tidak ada pengaturan jadwal oleh poli rehab. Terdapat pasien tidak bisa rehab sesuai protokol karena jadwal bersamaan dengan kontrol di poli lain yang seharusnya tetap bisa dilakukan pada hari yang sama.	
				Pelayanan sebelum tahun 2023 belum mencantumkan goal terapi dan hasil evaluasi	
				Terdapat pasien dengan goal terapi telah tercapai namun masih dilanjutkan program rehab yang sama/berbeda	
3	Kelengkapan administrasi rekam medis	Laporan Tindakan	Tidak Sesuai	Terdapat pelayanan tahun 2020 ke belakang yang tidak tercatat di CPPT	
				Terdapat Tindakan stimulasi otot yang belum dijelaskan pelaksanaannya apakah dengan modalitas atau dengan exercise	
				Tindakan rehab medik belum tertulis dilakukan oleh dokter atau fisioterapis	
				Terdapat pola penulisan hasil evaluasi yang berpola di beberapa pasien pada periode tertentu setelah skor VAS turun dalam bulan, namun bulan berikutnya naik kembali. Potensi kecurigaan manipulasi data.	
		Koding	Tidak Sesuai	Terdapat pasien dengan program rehabilitasi medik menahun dx stroke namun bukan untuk diagnosa stroke. Pada protokol masih tertulis diagnosa stroke sehingga ditagihkan dengan diagnosa stroke	

2. Kesimpulan

- a. Standarisasi penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medik mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Medik yang dikeluarkan oleh PERDOSRI, dimana didalamnya mengatur **frekuensi kunjungan, waktu evaluasi/re-asesmen dan goal terapi**. Standar tersebut dituangkan dalam PPK yang menjadi panduan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.
- b. Pada saat konsultasi atau evaluasi (re-asesmen) harus dituliskan ke dalam rekam medik sekurang-kurangnya memuat Subjective, Objective, Action, Planning (SOAP) yang berisi:
 - 1) anamnesis/keluhan pasien;
 - 2) objektif: catatan perkembangan pasien (meliputi pemeriksaan fisik dan/atau uji fungsi dan/atau hasil pemeriksaan penunjang);
 - 3) diagnosis medis dan diagnosis fungsi;
 - 4) tata laksana/ Program Rehabilitasi Medik;
 - 5) edukasi;
 - 6) frekuensi kunjungan;
 - 7) rencana waktu evaluasi (re-asesmen); dan
 - 8) rencana tindak lanjut (apabila diperlukan).
- c. Evaluasi (re-asesmen) harus dilakukan oleh Dokter Sp.KFR untuk menilai kondisi klinis dan kemampuan fungsional pasien serta menentukan Program Rehabilitasi Medik selanjutnya dengan mempertimbangkan goal therapy dan prognosis sesuai perjalanan penyakitnya, dan dikomunikasikan kepada DPJP Perujuk/dan atau FKTP perujuk dalam bentuk catatan perkembangan pasien terintegrasi.
- d. Semua Program Rehabilitasi Medik atas peresepan/preskripsi Dokter Sp.KFR dan secara administrasi dapat dibuktikan serta tercatat dalam rekam medis.
- e. Dipastikan ada rencana frekuensi kunjungan dan waktu evaluasi (re-asesmen) yang dapat dibuktikan secara administrasi dan dilampirkan dalam pengajuan klaim sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi.
- f. Pada kondisi tidak tercapai *goal therapy* setelah dilakukan sesuai rencana program dan memerlukan *prolong rehabilitation*, dilakukan evaluasi bersama antara Sp.KFR dan DPJP Perujuk untuk tindak lanjut dan tercatat dalam rekam medis serta dilampirkan dalam pengajuan klaim sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi.

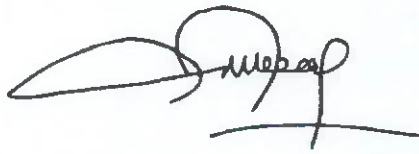
III. Rekomendasi

1. Untuk Fasilitas Kesehatan:

- a. Memastikan DPJP dan tenaga medis terkait mencatat dokumen rekam medis dengan lengkap dan tepat termasuk mencantumkan frekuensi kunjungan, waktu evaluasi/re-asesmen dan goal terapi.
- b. Melakukan utilization review mandiri dan audit medis mandiri atas data pelayanan rehabilitasi medik setiap 3-6 bulan termasuk evaluasi efektivitas terapi rehabilitasi medis bagi *prolong rehabilitation*.

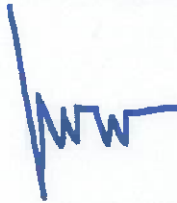
2. Untuk BPJS Kesehatan Cabang Utama Malang:
- a. Memastikan pemahaman verifikator terhadap administrasi klaim pelayanan Rehabilitasi medik
 - b. Melakukan audit kesesuaian dokumen pelayanan secara berkala, apabila ditemukan pelayanan yang tidak ada di rekam medis maka tidak dibayarkan.
 - c. Memberikan umpan balik utilization review pelayanan rehabilitasi medik setiap 6 bulan kepada FKRTL termasuk pasien dengan rehab terus menerus lebih dari 2 tahun, agar FKRTL melakukan telusur Kondisi Medis Pasien bersama DPJP

Malang, 06 Mei 2024
Anggota TKMKB Cabang Malang



dr. Rahmad, Sp.KFR.K.R. (K)

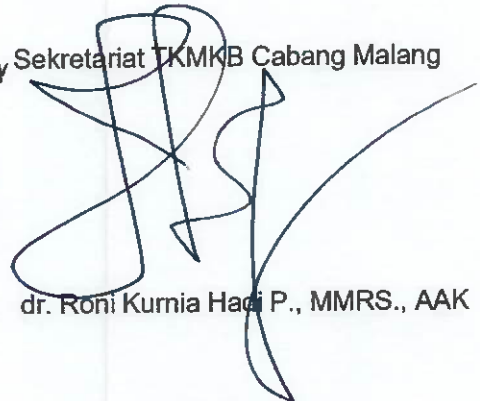
Ketua TKMKB Cabang Malang



dr. Sasmojo W., Sp.JP(K), FIHA,
FAsCC, FAPSIC, FSCAI



↓ Sekretariat TKMKB Cabang Malang



dr. Roni Kurnia Hadi P., MMRS., AAK